3. Лукас Э. Франкл и Бог. Москва: «Никея», 2020.

4. Мелехов Д. Психиатрия и актуальные проблемы духовной жизни. Москва: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2011.

5. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. Москва: Класс, 1994.

6. Мэй Р. Человек в поисках себя. Москва: Институт общегуманитарных исследований, 2015.

7. Строн Б. Бред Строн о интеграции религии и психотерапии. Ред. Пурена Д. // EXISTENTIA: психология и психотерапия, 2015 (8).

8. Ратцингер Й. Введение в христианство. Лекции об апостольском символе веры. Москва: Культурный центр «Духовная библиотека», 2006.

9. Тиллих П. Мужество быть. Избранное. Потрясение оснований. Москва – Санкт-Петербург: Центр гуманитарных инициатив, 2015.

10. Франкл В. Э. Основы логотерапии. Психотерапия и религия. Санкт-Петербург: «Речь», 2000.

11. Griffith J. L. Religion That Heals. Religion That Harms. A Guide for Clinical Practice. The Guilford Press, 2011.

12. Grun F., Halik T. Bóg zagubiony. Wiara w objęciach niewiary. Kraków: WAM, 2017.

13. Grzywocz K. Patologia duchowości. Od niezdrowej religijności do dojrzałej wiary. Opole – Zabrze: Manhu, 2017.

14. Janus D. Psychopatologia a religia. Warszawa: Eneteia, 2014.

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ И ИХ ТЕРАПИИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СЛУЧАЯ

Елена Бренер (Украина)

What anxiety means is it's as though the world is knocking at your door, and you need to create, you need to make something, you need to do sometning.
Rollo May (interview with J. Mishlove)

Целью данной работы является исследование феномена расстройств пищевого поведения и их терапии в экзистенциальной парадигме (следуя принципам и идеям экзистенциальной школы психотерапии). В дальнейшем тексте аббревиатура РПП будет использоваться для обозначения расстройств пищевого поведения.

Размышляя о том запросе, с которым приходит клиент, страдающий от РПП, в терапию, очевидно то, что она или он переполнены болью, которая для них самих заключается непосредственно в их симптоме, в том, что с ними сейчас происходит. Спектр физических и душевных страданий, которые они могут испытывать, весьма широк – от соматических болей и дискомфорта до выпадения волос и органических нарушений жизненно важных органов, от депрессивных состояний различной степени тяжести, самобичевания до суицидальных мыслей и поступков. Мотивированный болью клиент будет просить помощи в избавлении от симптома любыми реальными и нереальными способами. Нереальные – предпочтительнее, так как действуют быстро и гарантированно.

Мне близка позиция Бинсвангера, который, говоря о психическом расстройстве, описывает его как ловушку, возникающую в результате экзистенциальной несвободы человека и не позволяющую ему быть в мире, как он есть, среди вещей, какие они есть (Бинсвангер, 1999, с. 121-137). Как мне видится, это точно описывает

внутреннюю ситуацию клиента с РПП, как категорически не согласного с имеющимися данностями телесности и конечности. РПП в таком случае можно рассматривать и как системный симптом, копинг-стратегию, отражающую способ клиента встречи с тем, что Бинсвангер определяет как «антиномические напряжения», внутренние конфликты, которые являются неразрешимыми из-за экстравагантных (чрезмерных) идеалов (Бинсвангер, 1999, с. 211-221). Несмотря на весомый, согласно современным исследованиям, вклад генетической составляющей в развитие РПП, катализатором процесса, очевидно, является определённый невыносимый жизненный опыт, вытеснению которого и служит создание клиентом таких чрезмерных идеалов и замещение естественной многообразности жизни специфичным, очень ограниченным мироустройством.

Вне зависимости от того, где во времени разместился такой опыт – в далёком прошлом, в сегодняшнем настоящем или же он сопровождает клиента в течение всей жизни, клиент нуждается в этом симптоме для того, чтобы обеспечивать своё «безопасное» существование. До тех пор, пока сам симптом не набирает такой силы, что начинает угрожать жизни больше, чем фрустрирующее прошлое и настоящее, человек склонен не принимать его как проблему, требующую изменений. И в самых сложных случаях, даже тогда, когда физическое здоровье и жизнь находятся в опасности, человек, страдающий от РПП, оказывается настолько разрушен психически, что, может быть, вообще не в состоянии распознать, что с ним происходит.

Идея этого исследования заключается в описании терапевтической трансформационной парадигмы и качественных особенностей работы с такой проблематикой в экзистенциальном направлении.

Современное клиническое понимание РПП и факторы, влияющие на их формирование

Как мне видится, современный клинический взгляд отличается вычленением РПП из зависимостей и объединением значительной части РПП в группу расстройств, вызванных фундаментальными нарушениями образа тела (на фоне комплексных оснований генетического, социального, психологического генеза), вызывающими характерные избегающе-ограничительные паттерны в пищевом поведении. Основными типами, по которым развивается расстройство пищевого поведения, являются анорексия, булимия и компульсивное переедание.

Как указывает ряд современных авторов, термин «пищевая зависимость» является устаревшим и некорректным, проблемы РПП имеют определённое сходство с химическими и другими зависимостями, однако фундаментальное отличие заключается в том, что человек не может выжить без еды, это то, что должно оставаться в его жизненном поле, если он намерен продолжать существование. Наркотики, алкоголь, компьютерные игры, беспорядочные сексуальные связи – это то, без чего жизнь человека возможна, но с едой возникает принципиально другая ситуация: проблемы возникают как раз тогда, когда человек пытается взять под контроль свою физическую форму посредством ограничения себя в пище. Независимым от еды можно стать только будучи мёртвым, и этот принцип лежит в основе аноректического сценария. Второй вариант развития его же – когда человек, генетически менее толерантный к голоду (то есть не расположенный к чувству эйфории на фоне голода), пытаясь развить аноректический сценарий, полностью сбивает свои природные настройки и дифференциацию чувств голода и насыщения, что приводит к значимому снижению качества жизни, психическим и физическим нарушениям, характерным для нервной булимии, и компульсивному перееданию.

Понятие «образ тела» ввёл австрийский невролог и психоаналитик Пауль Шильдер, исследовавший искажённое восприятие тела на фоне повреждений мозга. В 1950 году он издал работу «Образ и наружность человеческого тела», где дал такое определение: «...картина нашего тела, которую мы сами формируем у себя в голове, другими словами, то, как наше тело представляется нам самим». Более широкое определение его идеи следующее: «Образ

тела включает в себя перцептивные, когнитивные и эмоциональные компоненты, формируется на основе жизненного опыта и отражает присущее индивиду мироощущение, психологические характеристики и проблемы» (Schilder, 1950). То есть понятие «образ тела» отражает синтез наших знаний и переживаний своего тела, накопленный в течение жизни. Это включает и отражение опыта наших отношений с другими людьми, начиная с первых значимых отношений «ребёнок – мать», и продолжается в текущем моменте во всех многообразных взаимодействиях с другими людьми.

Разные авторы, по-разному описывая характеристики позитивного и негативного образа, в основном сходятся в том, что позитивный образ тела является целостным, подвижным и живым. Живой в данном контексте означает, что человек спокойно и цельно воспринимает себя в пространстве и времени. Для ясности эту идею можно сформулировать в таком схематическом представлении: «Моё тело может быть разным, может меняться под влиянием времени и разных обстоятельств, тем не менее оно является моим, я не стремлюсь отчуждаться от него, я отношусь к нему с принятием и уважением в любом его виде». В обратной ситуации, когда человек привязан к статичной картинке представления о том, каким его или её тело должно быть, как оно должно выглядеть, и не принимает себя в многомерности проявлений реальной телесности, можно говорить о сформированном нарушенном (негативном) образе тела. Для такого переживания себя характерны чувства отторжения, неприятия тела или каких-то его частей, раздробленность телесного образа, акцентированное внимание на части тела, требующей улучшения, генерализованное отвращение к себе, распространяющееся на разные сферы жизни, склонность к насилию над собой (самоповреждающее поведение, ограничения, ригидные объективирующие установки и завышенные требования к себе), сниженная чувствительность к собственной боли как душевной, так и физической. Особенно важное значение в формировании негативного образа тела имеет ранний травматический опыт.

Особенность переживания тела человеком в современном мире – это снижение его функциональной значимости и повышение значимости социальной. Не так важно, какой результат способно произвести тело, гораздо важнее то, что производит интеллект. Однако при условии соответствия рафинированным телесным стандартам личность приобретает ощутимые социальные бонусы, связанные с принятием, одобрением и статусом. Как пишет в своей книге «Мнимые тела, истинные сущности» Николь Шнаккенберг: «Человеческое тело и его внешний вид тяжко обременены ценностью и насыщены смыслом» (Шнаккенберг, 2017, с. 24).

Проблема в том, что эти рафинированные стандарты являются недостижимыми для 95% человеческой популяции, и это неспроста. Человек – создание с чрезвычайно высокими параметрами адаптации: мы приспособились к совершенно разным, полярным условиям жизни, выживали и развивались как вид, беря у природы всё, что можно было взять, а иногда то, что нельзя, разрушая собственную среду обитания, но только сегодня Человек столкнулся с проблемой переизбытка калорий, и большая часть наших тел не приспособлена жить с минимумом жировой прослойки, как того требуют навязываемые из каждого утюга стандарты.

Для того, чтобы изменить свою генетическую программу хотя бы на какой-то период, среднестатистическому человеку придётся серьёзно ограничить себя в питании (в условиях постоянного столкновения с раздражающими факторами – семейная кухня, реклама продуктов, магазины, «социальная» еда и т. п.) и наполнить свою жизнь каждодневными и значительными физическими нагрузками. Если речь идёт о длительном устойчивом результате, то ценой такого результата будет жизнь в постоянных ограничениях, телесная боль, гормональные сдвиги, отсутствие сексуальной и жизненной энергии и, как следствие, колоссальный заряд постоянно аккумулирующегося напряжения. Сколько же такого напряжения может выдержать человек? На что он готов, чтобы избавиться от него или хотя бы облегчить свою задачу?

Роль индустрии красоты в росте РПП очень ёмко описана в книге Наоми Вульф «Миф о красоте». Люди по всему миру тратят миллионы долларов на то, чтобы бороться с собственными телами в стремлении соответствовать принятым стандартам красоты. В индустрию красоты входят такие сферы, как фитнес, диетология, пластическая (часто также и бариатрическая) хирургия, студии красоты, индустрия моды (к счастью, уже не в полном составе), психологический коучинг и др. Все эти сферы развиваются во многом за счёт прямой и опосредованной рекламы и формирования у потребителя представлений, поддерживающих необходимость тратить на них средства, что в свою очередь формирует установки о том, как нужно выглядеть, чтобы быть принятыми и успешными, и заставляет сравнивать своё тело с образами, предлагаемыми рекламой, расчленяя свой собственный образ тела на составляющие и искажая его в негативную сторону, так как, встав на путь такого сравнения, невозможно не отыскать несоответствия.

Такая токсичная роль среды становится критичной для психического здоровья, когда она проникает в сознание личности, не защищённой положительным опытом взаимодействия с первыми значимыми людьми. Этот опыт выражается в сформированном достаточно хорошем отношении к себе (личность принимает себя в целом и может о себе позаботиться), а также в устойчивых личностных ценностях (в том числе духовных). В этом смысле отношения, сформированные семьёй, могут играть решающую роль в развитии негативного образа тела и РПП.

Образ тела является динамическим, меняющимся конструктом восприятия, на который влияет огромное количество факторов, таких, как:

- наличие и качество телесного контакта с матерью;
- наличие раннего и подросткового травматического опыта (физическое, психологическое насилие);
- вовлечённость в профессиональные занятия спортом, танцами и т. п., сопряжённые с жёсткими требованиями поддержания определённого веса с детского и подросткового возраста;

- качество опыта телесного взаимодействия с другими людьми;
- вербальные и невербальные оценки, получаемые от других людей в течение жизни; особенно важны ранние оценки значимых людей и референтных групп, полученные до формирования идентичности (ориентировочно 17–20 лет);
- информационная, медийная среда;
- общественные стереотипы, в частности – патриархальные установки и сила их влияния на конкретного индивидуума.

Отдельной строкой хочется отметить роль медицинских работников в стигматизации полноты, формировании нездорового отношения и социальных предубеждений против полных людей. Многие из моих клиентов с удивлением узнают от меня о том, что статистически риски пережить хирургические вмешательства у полных людей выше, чем у худых, что полнота – понятие условное и как таковое не имеет отношения к здоровью, что человек, ИМТ (индекс массы тела) которого выходит за рамки 18,5–24,99, может быть абсолютно здоровым и не нуждаться ни в каких поправках в питании и активности, а диетирование любого формата способно причинить намного больший вред человеку, чем «высосанный из пальца» лишний вес. Кажется, сложно переоценить роль образовательных программ для профессиональных медиков, которые позволяют им пользоваться не только уже имеющимися знаниями и опытом, но и результатами новых научных исследований и статистических данных.

Чрезвычайно часто приходится сталкиваться в практике с психологическими травмами разного характера, нанесёнными медиками, что говорит о проблемах с базовой психоэдукацией медработников, отсутствием внимания к последствиям оценочных суждений, негативистских и токсичных посланий, трансляции изживших себя или непроверенных данных с экспертной позиции: «Вам нужно срочно худеть!», «А что вы думали при таком весе, как у вас?!», «Как же вы довели себя до такого?!», «С вашим весом неудивительны такие проблемы» и т. п. Людей на постсоветском

пространстве сложно поразить подобными фразами врачей, мы привыкли внимать им с пиететом и доверием, поэтому часто не замечаем нарушений своих границ и откровенной токсичности таких высказываний, проглатывая и интериоризируя их в свои представления о себе. Однако эта проблема не является исключительной для какого-то особого менталитета: один из пяти пациентов в медицинских учреждениях США сталкивается с дискриминацией по таким основаниям, как гендер, раса, возраст, хронические заболевания, обеспеченность, вес и внешность.

Одним из примеров применения устаревших и неадекватных инструментов является использование медиками и диетологами шкалы BMI (body mass index), или ИМТ, как ультимативного метода определять дефицит или избыточный вес, делать на этой основе выводы о здоровье или нездоровье пациента и составлять рекомендации для набора или сброса массы тела. Однако надо сказать, что шкале, созданной в 1830 году Альбертом Кветеле, математиком и социологом, почти 200 лет, и она не имеет в своей основе не только базовых современных знаний медицины и антропологии, но также и не учитывает пол, возраст, генетические различия и является абсолютно не релевантной для людей, занимающихся спортом. На сегодняшний день BMI может считаться не более чем условной шкалой, которая не может использоваться как выделенный диагностический инструмент. В данной работе приводится расчёт по BMI для наглядности динамики пациентки и развития/снижения рисков.

Описание случая

Клиентка, случай которой я описываю в этой работе, за время нахождения в терапии продемонстрировала симптоматику двух ключевых расстройств пищевого поведения: анорексии и компульсивного переедания (BED – *Binge eating disorder*). Трансформация анорексии в BED является одним из характерных путей протекания расстройства, особенно в ситуации раннего обращения за помощью. Анорексия на стадии выздоровления часто перетекает в

булимию или BED, при которых вес пациента значительно меняется в сторону здорового или становится таковым, но психологическое состояние, особенно субъективное его переживание (внешние проявления могут отсутствовать) становится крайне угнетённым, вплоть до клинической депрессии и суицидальных намерений. В связи с такой меняющейся симптоматикой определение данного случая как «расстройство пищевого поведения ограничительно-избегающего типа» кажется более подходящим, чем анорексия.

Клиентка Валерия, 21 год, студентка, будущий архитектор, обратилась за помощью с низкой самооценкой и неуверенностью в себе. При первой встрече я обратила внимание на то, насколько Лера оказалась непохожей на взрослую девушку: ей можно было дать максимум лет 15–16, худенькая, детское личико без косметики, косички, смешные яркие носочки, короткая юбка и рубашка в клетку, взгляд перемещается в пространстве с предмета на предмет, практически не встречаясь с моим. Она залезла в кресло с ногами, обняв колени и развернувшись от меня вбок, начала свой рассказ о себе, тараторя и хихикая, особенно сильно в тех местах, которые касались её обид и печалей, которые в основном концентрировались вокруг отношений с отцом и парнями. По рассказам Леры, отец постоянно критиковал её внешность, часто в грубой форме. Мог, например, спокойно сказать за завтраком: «С твоими ногами нужно в спортзал ходить, а не жрать». Мог назвать её «жирной кобылой» и едко высказаться по поводу какой-то части её тела, которая, по его мнению, требовала коррекции. Про молодых людей он тоже высказывался вполне однозначно: «Ну что ты думаешь, ты нужна ему такая? Он тебя использует и бросит». И действительно, с ухажёрами Леры всё происходило именно так: уже третий парень, и снова, по его инициативе, отношения закончены. «Они все меня бросают, значит, папа прав, всё так, как он говорит, я никому не нужна такая... никакая». Лера очень себе не нравилась, как она себя видела: её ноги слишком толстые, попа неправильной формы, живот «жирный и выпирает». На момент обращения Леры в терапию её вес составлял 54 кг при 167 см роста, ИМТ составлял 19,4, что приближалось к

нижней границе условной нормы (18,5–24,99). За предыдущие три месяца она похудела на 7 кг: «Папа сказал, мне надо худеть». Лера тренировалась четыре раза в неделю, ограничивала себя в еде, особенно во второй половине дня, и собиралась продолжать это делать, «пока не стану стройной: с нормальной маленькой попой и без живота». Живот был особенным местом для Леры, на нём концентрировалась её ненависть к своему телу. Он вызывал очень много негативных чувств и переживаний. Когда Лера смотрела на себя в зеркало, увидеть себя полностью ей не представлялось возможным: она видела только живот, как он торчит, выпирает, иногда (крайне редко) исчезает, замечала различия между «животом после завтрака» и «животом перед месячными». Не было целостного образа себя, был образ живота, который формировал образ тела. Мироощущение моей клиентки во многом зависело от того, каким она увидела свой живот сегодня утром. Если он казался ей выпирающим и недостаточно плоским, то тогда она неудачница, бесполезное существо, никому не нужное и не имеющее ценности. Ещё Лера очень боялась стать похожей на маму. Живот мамы не был плоским, и папа не уставал его комментировать и насмехаться и над мамой при дочери, только мама никак на это не реагировала. Она давно решила молчать, «чтобы не ссориться», «ведь мы хорошо живём, у нас всё есть, мы ни в чём не нуждаемся, зачем портить отношения?»

К окончанию первичного договора на 10 сессий Лера подошла с весом 52 кг, что соответствовало BMI 18,65 (является гранью условной нормы), и сформированной зацикленностью на еде. После этого, несмотря на рекомендации терапевта, Лера решила приостановить терапию в связи с отъездом на полугодичную стажировку за рубеж.

Через 7 месяцев Лера обратилась за помощью снова. Вес 43 кг, ИМТ 15,4, отсутствие менструаций последние четыре месяца. Был заключён годичный контракт, фактически продлившийся 8 месяцев (34 сессии), пока клиентка не разорвала его досрочно по собственному желанию. Цели терапии: терапия анорексии в сотрудничестве с психиатром и консультантом по питанию. Это подразумевало

набор веса (договор на 50 кг и отказ от контроля веса клиенткой) и работу по снижению интенсивности навязчивых мыслей о еде.

Работа терапевта была направлена на создание доверительной среды, которая позволила бы работать с нормализацией чувств, налаживанием контакта с телесностью и чувствительностью, помощью в отражении, описании и определении роли значимых феноменов в жизни клиентки.

Разворачивая свои переживания в терапии и начиная осознавать себя и свои границы, свою телесность и ощущения, которые она приносит, свои внутренние процессы, клиентка стала продвигаться к выбору сепарации и автономии от родителей. Значительным сдвигом в этом направлении послужило выявление и высвобождение её злости на мать и отца. Появилось критическое мышление по отношению к ним. Лера начала проявлять эти чувства и очерчивать собственные границы отношений с родителями, дверь в её комнату теперь была не просто закрыта (раньше, по настоянию отца, дверь была всегда открытой, и он мог в любой момент войти без стука и разрешения), но на ней появился и внутренний замок.

В терапевтических отношениях это проявлялось отсутствующими ранее вспышками недовольства и протеста на какие-то, на первый взгляд, нейтральные вопросы терапевта. Лера активно отстаивала своё право на самоопределение.

Одновременно с этим Лера жила во внутреннем конфликте между желанием быть активной и здоровой, не зависеть от еды и веса, но оставаться худой, не возвращать потерянные килограммы. Тем не менее пищевые привычки удалось немного откорректировать, и через несколько месяцев психотерапии, фармакотерапии и поддержки нутрициолога вес Леры достиг 49 кг, восстановилась менструация. Со снижением проявлений анорексии Лере стало сложнее управлять тревогой посредством голодания. Голодание стало восприниматься клиенткой как вид самоповреждения, насилия и причинения боли самой себе. Теперь не подавляемая голодом тревога постепенно выходила на первый план наших встреч. Лера рассказывала о появившихся ночных приступах непонятного

страха, об ощущении «страшной чёрной пустоты в районе живота», о непреодолимом желании заполнить её хоть чем-нибудь. «Иногда, обычно ночью, когда мне очень страшно, я чувствую ужасную чёрную пустоту внутри себя. От неё некуда деваться, и кажется, что лучше умереть, только чтобы её не чувствовать. Но я не хочу умирать, просто мне очень страшно». На таком фоне стали появляться первые приступы переедания, которые очень пугали Леру, так как контроль совершенно терялся, Лера чувствовала себя как будто без сознания, поглощая пищу без контакта с чувством насыщения, она не могла остановиться, пока пища не заканчивалась. Лера часто плакала, испытывала приступы беспокойства. Особенно её пугали размышления об отдельной от родителей жизни, появлялся ужас при мысли о том, что она каким-то образом может их потерять. На этом фоне, усугублённом произошедшим в это время разрывом с подругой, вечерние приступы страха стали регулярными и появились суицидальные мысли, без намерений.

Вместе с тем Лера отмечала, что в её жизни появилось больше ясности, с готовностью обсуждала свои страхи и тяжёлые переживания, связывала события в жизни с обострениями тревоги. Чем больше мы говорили о страхах, тем больше раскрывался её ужас перед одиночеством. Она чувствовала себя парализованной своим знанием о том, насколько страшен мир и как слаба и беспомощна она сама перед ним. Терапевт здесь работала над адекватным контактом с реальностью: Лера не была слабой, она могла постоять за себя, была целеустремленной и умела трудиться, не сдавалась перед сложностями и неудачами, имела значительные успехи в учёбе, жизнь была не такой беспросветной и одинокой, как указывала ей пустота внутри, которая всегда сообщала ей одно и то же мощное послание о том, что она маленькая, беззащитная девочка, не имеет права чего-то хотеть или делать самостоятельно, она – продолжение или функция родителей и без них ничего не стоит. Тогда отделение от родителей означает одиночество, а одиночество невыносимо пугало.

Однажды Лера пришла на встречу с горящими глазами и

заявила, что вдруг поняла, как сильно злится на обоих родителей: на отца – за весь его яд, за оскорбления, за непозволительные нападки на её тело, за то, что её никогда не бывает достаточно, чтобы он был доволен, за то, что она для него всего лишь фасад, которым можно хвастаться перед знакомыми, и ему начхать, что она чувствует; на мать – за то, что никогда не могла остановить отца, никогда не могла её защитить, никогда не была на её стороне по-настоящему. Вся сессия была посвящена её злости, она изливалась и изливалась, казалось, что если бы время не подошло к концу, то поток лился бы ещё столько же. После этой сессии Лера стала приносить детские воспоминания из прошлого, связанные с обидами на отца и мать. Все они были пронизаны разочарованием и болью отвержения её Я. Желания Леры не принимались взрослыми во внимание, они всегда знали, как ей лучше, что ей есть, носить, как причёсываться, чем заниматься, с кем дружить и т. д. Лера вдруг осознала, что до терапии всю одежду она покупала только вместе с матерью и только то, что мать одобряла. На предпоследней сессии Лера горько плакала: она вспомнила о том, как в 8 лет сильно хотела на день рождения сиреневый самокат, украшенный разноцветными кисточками и рисунками, но взрослые решили, что он «слишком размалёванный» и вообще «он тебе не нужен». Год ушёл на просьбы и мольбы к родителям, и в результате самокат купили, но не тот, что хотела Лера, а тот, что понравился маме.

Терапию Лера решила прекратить после этой сессии про самокат. Вначале она прервала связь, потом пришла и рассказала, что крайне расстроена поведением терапевта. Ведь она плакала, она переживала своё детское горе, а терапевт закончила сессию по расписанию, как ни в чём не бывало. Не задержала её ни на 10, ни даже на 5 минут, а ведь она плакала! На этой сессии Лера высказала мне все накопленные претензии: про то, что пропустить сессию без предупреждения нельзя, про то, что стоимость терапии неоправданно высока, про то, что терапевту на самом деле всё равно, что с ней будет и так далее. Думаю, здесь Лера попала в свою детскую травму отвержения и игнорирования, которая совпала с кризисом раскрытия

и принятия права на злость. Злости оказалось так много, что Лера отказалась продолжать терапию. К этому времени приступы тревоги беспокоили её намного меньше, она стала позволять себе питаться разнообразно, и еда перестала занимать центральное место в сознании, периодически происходили бинджи, неконтролируемые приступы обжорства.

Несмотря на досрочно прерванный контракт, терапия видится достаточно успешной. Очевидно также и то, что клиентка не получила всего объёма помощи, который был возможен. Согласно исследованиям эффективности терапии, 14 встреч являются достаточными, чтобы значительно облегчить хронические симптомы, и только после 104 возможны изменения характерологические. Возможно, и Лера, чей случай был описан выше, когда-нибудь продолжит свой путь к себе с другим терапевтом, и хочется верить, что тот опыт, который она получила в терапии, сослужит ей в дальнейшем.

Центральные проблемы РПП сквозь призму экзистенциальных данностей

Базовыми для любого варианта развития РПП видятся патологические отношения с тревогой; деструктивный способ совладания с ней является центральным механизмом, запускающим расстройство. Склонность клиентов с РПП консервировать тревогу в попытке её избежать становится, по сути, стратегией избежать жизнь. Появляется сверхценная, страстно желанная идея: быть худым. Например, чтобы не быть, как мать или как другие люди, «не справившиеся с собой» (со своим инстинктом есть пищу, иметь желания и жить), а стать лучше, «выше», чем все остальные, победить своё тело посредством железной воли, которую Ролло Мэй описывал как «репрессивный тип силы воли» (Мэй, 2005, с. 446), направленный на подавление желаний и стремлений и в результате сильно обедняющий внутреннюю жизнь человека, вызывая общую подавленность, враждебность к себе и другим.

Такая игра затягивает и может приносить бонусы в виде «отвесов» каждый день или приступы обжорства/рвоты, доводящие до отчаяния. И то, и другое вызывает сильные чувства: или эйфорию с чувством превосходства, или разочарование со злостью на грани безысходности. Человек оказывается вовлечённым во внутренне очень бурную и изматывающую деятельность, которая не приносит развития и пользы для его жизни, делает его существование мучительным и в результате может его убить.

Одним из выраженных свидетельств нарушенных отношений с миром и переживания его как хронической Тревоги является сверхценность первичного значимого объекта для формально взрослого человека. На примере приведённого клинического случая в начале терапии очевидна особая защитно-ограждающая роль родителей для Леры. Их образы «желающих-только-добра» как будто отделяют клиентку от других людей (обязательно враждебных), и родители возводятся на пьедестал непогрешимости и неприкасаемости. «Каждый сам за себя, и никому ты не нужен, кроме родителей. Только родители готовы о тебе заботиться просто так, и поэтому они первые и самые главные люди на земле. Чтобы они ни делали, это правильно, и они хотят мне только добра». Так Лера описывала свои представления о родителях, и в её 21 год они видятся по-детски сакральными, не подлежащими критике и отсоединению. Такое слияние, явно не соответствующее возрасту, очевидно говорило об отказе принимать ответственность за свою жизнь и о стремлении избежать встречи с такой экзистенциальной данностью, как Свобода. «Всем людям на тебя или начхать, или они хотят тебя использовать. Просить других о помощи нельзя, это значит, что ты слабый». Лера прямо говорила о своём недоверии к миру и другим людям, она не ожидала от них ни поддержки, ни понимания. Получить от кого-то помощь означало расписаться в собственном бессилии, бесполезности и быть в долгу перед кем-то. Суть человеческого существования выглядела в её глазах как конкуренция за достижения, качество жизни и соответствующий социальному запросу внешний вид. Жизнь представлялась наполненной ожиданием испытаний и встречи с непременно злыми

и корыстными намерениями других людей; только тяжёлый труд и усердие могли помочь с этим справиться и набрать очки в схватке за привилегии. «Я не люблю бездельничать, только паразиты так делают. Нормальные люди должны работать и стараться быть лучше всех». Лера училась в двух высших учебных заведениях одновременно, у неё почти не было свободного времени, много часов она проводила за занятиями, училась на нескольких языковых и дизайнерских курсах, не понимала, «как и зачем люди гуляют в одиночестве», всё свободное время проводила за дополнительной учёбой и редким общением с друзьями. Такая настроенность на межличностную изоляцию указывала на высокую тревожность и недоступность интегрированного переживания собственного одиночества, экзистенциальной Изоляции и Вброшенности. В любые моменты приостановки от «деланий» Леру затопляла тревога, иногда переходившая в ужас, которые она описывала как «чёрную дыру где-то внутри живота». Ключевым в терапии видится выявление и определение места Тревоги в жизни клиента с РПП, обучение замечать её и разделять патологическую тревогу от условно нормальной (обусловленной реальностью).

Безусловной составляющей РПП являются сложные отношения с Конечностью бытия, которые так или иначе открываются в процессе работы. Особенно сильно это проявляется у больных анорексией подростков: хроническим голоданием они останавливают и психологические, и физиологические процессы взросления, как бы останавливая время и сопротивляясь конечности (на начальном периоде это сопровождается чувством эйфории и превосходства), на самом деле в какой-то точке включая стремительный обратный отсчёт к смерти.

Борьба с физичностью собственного тела является борьбой с природой и её законами. Она отражает отказ личности принять тот факт, что тело меняется со временем и что для тела естественно отражать опыт человека физически, естественно менять вес и форму тела, качество и цвет волос и кожи, естественно стареть и умирать.

В этом случае данности Вброшенности-в-Мир и Конечности

остаются не пережитыми и не принятыми. Озабоченность недопущением физических изменений становится обсессивной, и на это тратится огромное количество личностного ресурса: временного, физического, финансового, интеллектуального. Силы и время молодого продуктивного человека уходят на борьбу с явлением неизбежным и неотвратимым, оттягивая ресурсы от самореализации и заранее лишая удовлетворения от жизни в те годы, когда/если старость всё-таки наступит.

По сути, человек занят процессом убийства себя через элиминирование своих желаний и истинных проявлений, погружаясь в бессилие безысходности и внутреннюю пустоту. Зрелый по возрасту человек остаётся ребёнком, который не может интегрировать данность своей природы и понять её смысл для своего развития. Невозможно принять вызов Осмысленности и создать свой собственный смысл жизни тогда, когда всё твоё существо подчинено «экстравагантному идеалу» по Бинсвангеру (Бинсвангер, 1999, с.121-137) или тому, что если исключительно хорошо постараться, то бессмертие и остановка времени станут реальностью.

Такое нежелание принимать «прозаическую» реальность кажется связанным со страхом перед Свободой как перед принятием ограниченности жизни и имеющихся возможностей, перед признанием неизбежности выбора и потерь, отсутствием гарантий «правильности» решений и всего того, с чем приходится сталкиваться Свободному человеку на пути к реализации.

Качественные особенности экзистенциальной практики в клинической ситуации с РПП

Если смотреть на жизнь клиента с РПП сквозь призму онтологического и онтического бытия, то очевидно, что она протекает только в сфере онтического: будучи посвящённой миру вещественного/телесного, она сосредоточена на теле как на главном и единственно возможном модусе бытия, постепенно вытесняя все другие способы осознавания себя и со-бытия с другими, погружая тело в бесчувственность, сознание – в забвение от себя самого и изоляцию

от других. И это определяет сложность работы с таким клиентом в онтологическом модусе, заставляет задуматься о том, насколько это возможно для этого человека вообще – заметить себя по-другому и переключиться с мира вещей на мир сознания, можно ли как-то помочь этому переключению с точки зрения развития терапевтического контакта и альянса.

На примере случая Леры видно, насколько сложно такому клиенту допускать существование иррационального, принимать нематериальные ценности и предположить духовные основания жизни. «Абстракция – это не живопись», – такими словами Лера критиковала символические картины в моём кабинете: так же как и в жизни, её раздражало в них неконкретное, непонятное и недосказанное. Лера отвергала подобные проявления жизни, объясняла такое поведение других людей их «сумасшествием», наивностью или, наоборот, скрытым умыслом. Лера обесценивала и терапию, говорила о том, что не замечает в себе перемен и пользы от того, что происходит в кабинете. Ведь это не лечение, и нет доктора, который ставит диагноз, даёт таблетки – тогда было бы всё понятно. Переживать неопределённость бытия означало потерять контроль, на который Лера тратила очень много усилий. С этой точки зрения было очевидно её раздражение и нетерпимость ко всему, что ставило под сомнение и ослабляло контроль, потому что тогда Тревога затапливала её.

Парадоксально, что если в «обычной» жизни люди могут себе позволить свободно перетекать из онтического в онтологическое, и это, скорее, норма для зрелой личности, чем нечто особенное, то в контексте РПП переход из онтического модуса в онтологический может означать отказ от смерти и принятие жизни.

Как мне видится, основной вызов экзистенциальной работе с клиническим случаем – это масштаб симптома в рамках жизненной картины клиента. Симптом на определённом этапе своего развития может полностью заслонять мир человека и быть настолько огромным и определяющим всё происходящее, что это также может создать сложность и для терапевта увидеть клиента и его жизнь

достаточно объёмно и целостно. И тогда особенностью терапевтической работы видятся не какие-то технические приемы или, например, специфические темы, которые будет вносить терапевт, имея в виду возможность справиться с задачей клиента или его близких, но внутренняя ориентация терапевта на такое расширенное видение жизни клиента, которое даёт возможность распознать то, что Бинсвангер называет «заброшенностью» и «бытием-подвлиянием». Расширить взгляд клиента на себя самого, помочь обнаружить и осознать свои способы обращения с жизнью и своими возможностями и есть, на мой взгляд, практическое выражение экзистенциальной терапевтической работы.

В отличие от многих других направлений психотерапии, экзистенциальная терапия не ориентирована непосредственно на изменение определённых методов реагирования клиента и его поведенческих паттернов, но это то, что может произойти, когда человек расстаётся с основаниями устаревшего поведения и приобретает другие опоры. Такая структура объясняет относительную долговременность экзистенциального подхода, когда клиент скорее сам получает возможность определить, что стоит за его нежелательным поведением или жизненными ситуациями и осознать выбор, который предстоит сделать более ясно и ответственно. Мне видится такой подход более эффективным в долгосрочной перспективе, так как устойчивую реальную опору можно приобрести только в самом себе, а не в другом человеке, помогающем тебе посредством обучения или наставничества. Именно поэтому, мне кажется, директивные методы и отношения работают ограниченно или вообще не работают, и в долгосрочной перспективе не делают человека удовлетворённым собой.

Отличие экзистенциальной парадигмы – это равные отношения в терапии, которые становятся возможными благодаря Открытости и Свободе терапевта, признанию одинаковости человеческой ситуации терапевта и клиента вне зависимости от того, в каком месте своей жизни сейчас находится клиент, обратившийся за помощью. Такая работа, будучи уникальной и во многом

непредсказуемой по времени, не может быть краткосрочной и уложенной в определённые временные шаблоны, и экзистенциальные терапевты предпочитают об этом говорить открыто и с самого начала отношений.

Внимание к переживанию жизни, к непрерывности меняющегося опыта, к тому, как формируется и проявляется отношение к себе и своей жизни, ценностям, данностям и сложностям, для меня определяет особенность экзистенциального подхода. Клинический симптом же очень настойчиво говорит о себе в терапии, он – причина того, что клиент оказался в кабинете у терапевта, и всей своей болью предъявляет себя и клиенту, и терапевту, через клиента или иногда родственников настойчиво сообщает о необходимости «сделать что-то с этим». Думаю, что действительно важным в этом случае является работа в тандеме со смежными специалистами, которая позволяет разделить ответственность за клиента и разграничить психотерапию и другие необходимые виды помощи. В случае с Лерой психиатр и нутрициолог занимались таким необходимым «деланием»: непосредственными мерами, связанными с физиологической и психической стабилизацией, которая являлась необходимой основой для психотерапевтической работы.

Такое разделение ответственности и избегание смешения ролей (как если бы терапевт занимался вопросами питания и/или фармакотерапии) позволило сконцентрироваться на широкой исследовательской работе, посвящённой миру клиентки и тому, как она его переживала. Мне видится, что основой экзистенциальной практики как раз является этот исследовательский фокус. Он позволяет клиенту расширять взгляд на собственную жизнь: проявлять свою жизненную ситуацию, более ясно обнаруживать убеждения и чувства, рассматривать и задумываться над их истинным смыслом для себя.

Безусловно, этот фокус включает и вопросы, связанные с телесностью (если вообще существуют вопросы, не связанные с ней тем или иным образом). И в контексте работы с РПП внимание к телесности и объективной реальности нашего существования в теле

будет ключевым, так как именно в том, какие пути для решения вопросов ограниченности, изменчивости и несовершенства тела выбирает клиент, и заключается основная его проблема.

Заключение

Качественной особенностью экзистенциального подхода при терапии РПП мне видится создание терапевтических отношений на основе концептуального, целостного восприятия личности и жизни клиента. Жизнь в этих отношениях помогает клиенту осознать существующие внутренние напряжения и конфликты, интегрировать фрустрирующий опыт, а в дальнейшем – уменьшить интенсивность фрустрирующих переживаний. Терапевтическая работа фокусируется на возвращении клиенту психической и телесной чувствительности, выстраивании адекватных отношений с данностями человеческого бытия, поиске новых экологичных стратегий совладания с переживаниями и, самое главное, – на создании клиентом собственной внутренней опоры, основанной на самосострадании, принятии себя и заботе о самой или самом себе. Важной частью этих отношений также видится терапевтическая работа по открыванию и связыванию онтологического переживания жизни с онтическим, помощь клиенту в налаживании реалистичных отношений с миром материального и обнаружении собственных духовных ресурсов для того, чтобы с этим справляться.

Экзистенциальный подход помогает рассмотреть ситуацию клиента с РПП в рамках жизненного континуума, воздерживаясь от оценок и рекомендаций и не вручая инструментов по борьбе с собственными проявлениями. Выявляя свои чувства, парадоксы, конфликтующие убеждения, иллюзии и т. д., клиент продвигается к более полному пониманию себя, результатом которого в достижимом идеале является определённая личностная зрелость и возможность принятия непростых реалий жизни.

Встреча с собственной душевной силой посредством расширения своего сознания позволяет человеку примириться с телесной ограниченностью и смертностью и, как мне кажется, отражает

трансформационную парадигму экзистенциальной работы с РПП: репрессивная по отношению к телу и личности «сила воли» может стать дорогой к освобождающей силе духа.

Литература:

1. Бинсвангер Л. Бытие-в-мире. Рефл-Бук, Ваклер, 1999.

2. Бинсвангер Л., Мэй Р., Роджерс К. Три взгляда на случай Эллен Вест // Московский психотерапевтический журнал, № 3, 1993.

3. Вульф Н. Миф о красоте. Москва: Альпина Паблишер, 2016.

4. Кибитов А. О., Мазо Г. Э. Генетические факторы патогенеза и клиническая генетика приступообразного переедания // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова, 2016, №116(7), 113-119.

5. Лапина Ю. Тело, секс, еда и тревога. Москва: Альпина нон-фикшн, 2018.

6. Манн Т. Секреты лаборатории питания. Москва: Альпина Паблишер, 2017.

7. Мэй Р. Любовь и воля. Киев: PSYLIB, 2005.

8. Хирш М. Это мое тело... и я могу делать с ним что хочу. Москва: Когито-Центр, 2018.

9. Шнаккенберг Н. Мнимые тела, подлинные сущности. Калининград – Москва: «Phoca Books», 2017.

10. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. РИМИС, 2008.

11. Arcelus J., Mitchell A. J., Wales J., Nielsen S. Mortality rates in patients with anorexia nervosa and other eating disorders. A meta-analysis of 36 studies // Arch Gen Psychiatry, 2011, 68(7), 724-731.

12. BHF-funded research at the University of Leicester (UK) // https://www.bhf.org.uk/what-we-do/news-from-the-bhf/news-archive/2017/january/being-overweight-may-protect-patients-during-heart-surgery.

13. Crow S. J., Peterson C. B., Swanson S. A., Raymond N. C., Specker S., Eckert E. D., Mitchell J. E. Increased Mortality in Bulimia Nervosa and Other Eating Disorders // American Journal of Psychiatry, Vol. 166 (12), 2009, 1309-1311.

14. Fairburn Ch. G. Overcoming Binge-Eating. Guilford Press New York – London. Reprinted from Eating Disorders Review, September/October, Volume 24, Number 5, 2013.

15. Grogan S. Body Image: Understanding Body Dissatisfaction in Men, Women and Children (3rd edn.). London and New York, Routhledge, 2017.

16. Trace S. E., Baker J. H.,Peñas-Lledó E., Bulik S. M. The Genetics of Eating Disorders // Annual Review of Clinical Psychology, Vol. 9, 2013, 589-620.

17. Schilder P. The Image and Appearance of The Human Body. New York: International Universities Press, 1950.

18. Nguyen T. T., Vable A. M., Glymour M. M., Nuru-Jeter A. Trends for Reported Discrimination in Health Care in a National Sample of Older Adults with Chronic Conditions // Journal of General Internal Medicine, 2018, 33, 291-297.